

SOAL 3



RESUME RAWAT INAP

Nama Pasien	: Ny. ***	Tgl. Masuk	: 06-05-2025
No. RM	: 00-84-56	Tgl. Keluar	: 10-05-2025
Tgl. Lahir	: xxx	Lama Dirawat	: 4 Hari
No JKN	: xxx	Jenis Kelamin	: Perempuan
No SEP	: 2**7R0**0525V00***4	Alergi Obat	: Tidak Ada

Keluhan Utama	Nyeri perut hilang timbul (-) kontraksi (-) keluar air (+) sejak pukul 10.00 (06/05/2025)
Perkembangan Selama Perawatan	Pasien datang dari IGD diantar oleh keluarga dengan keluhan Nyeri perut hilang timbul (-) kontraksi (-) keluar air (+) sejak pukul 10.00 (06/05/2025) Lakmus (+), gerak janin (+) baik sejak Februari 2025, UL : (+) 2, TD 2x cenderung tinggi, os masuk perawatan untuk dilaksanakan tindakan SC a.i PEB SC terlaksana dengan baik, bayi lahir utuh laki-laki BBL : 2900 gr, menangis kencang, observasi ketat post operatif, dilakukan
Pemeriksaan Fisik	*Kesan Umum : nyeri perut hilang timbul (-) kontraksi (-) *Kesadaran : CM, *Nyeri : 0, *GCS : 15 (E : 4 / M : 6 / V : 5) * Tensi Darah ke-1 : 171 / 103 mmHg * Tensi Darah ke-2 : 170 / 100 mmHg * Nadi : 129 x/menit, * RR : 18 x/menit, * Suhu : 36 derajat C * BB sebelum hamil : 80 kg → BB setelah hamil : 95 kg * Lingkar Lengan Atas (LILA) sebelum hamil : 32 cm * Lingkar Lengan Atas (LILA) setelah hamil : 34 cm * TB : 156 cm * BMI : 32.9 kg/m² Asuhan Gizi ; oleh dr. G**** P*** Sp.GK P (Problem): Kelebihan asupan energi dan lemak (NI-1.5) E (Etiology): akibat peningkatan konsumsi makanan tinggi energi, gula dan lemak dengan aktivitas fisik rendah pasca hamil S (Sign/Symptom): ditandai dengan IMT 39.0 kg/m², BB naik 15 kg dari sebelum hamil, dan asupan energi melebihi kebutuhan harian. Diagnosis Gizi : <u>Obesitas derajat II (Malnutrisi) akibat ketidakseimbangan asupan dan pengeluaran energi</u>

	Kesimpulan : Pasien dengan obesitas derajat II (IMT 39.0 kg/m ²) dan DM tipe 2 selama 17 tahun memiliki HbA1c 7.7% (kontrol glikemik kurang baik). Diberikan Diet Rendah Kalori & Indeks Glikemik (1.600 kkal/hari) serta edukasi, pola hidup sehat dengan target penurunan berat badan 0.5–1 kg/minggu dan perbaiki HbA1c <7%
Pemeriksaan Penunjang	Cardiotocography (CTG) (+) Radiologi Thorax Hasil Laboratorium : Lakmus (+) , UL : Protein Urine +2, HbA1C : 7,7 BS (06/05/2025) : 271 , SHK (+) : sampel tumit diambil pada 08-05-2025 08.00
Diagnosis Utama	G2P1A0 36 Minggu 5 hari T/H dengan Pre Eklamsia Berat (PEB)
Diagnosis Sekunder	KPD 3 jam DM Tipe 2 dengan Obesitas grade 2 Persalinan Prematur
Tindakan Utama	Seksio Cesarean Lower segment uterine
Tindakan Lainnya	Cardiotocography Laboratorium darah
Obat yang diberikan selama perawatan	Ranitidin HCl 50mg/2ml amp inj(A). [1] Metoklopramid 5mg/ml injeksi(a). [1] Nifedipine 10mg Tablet(e). [10 caps] Magnesium Sulfat(MGSO ₄) 40%. [1] Sefazolin 1gr Injeksi(d). [2] Infus Naci 0,9% 100ml(kf).. [1] Air untuk injeksi 25ml(kf). [3] Metidopa(Dopamet) 250mg Tablet(aam). [6 caps] Oksitosin 10IU/ml Injeksi(apl). [2] Parasetamol 500mg Tablet(pp).. [4 caps] Ondansetron 4mg/2ml Injeksi(dexa). [1] Insulin Ezelin 300IU/3ml Pen(k) [1] Fentanyl inj 2ml (k). [3] Tablet tambah darah (triman). Sulfas Ferosus 300mg [2] Natrium Diklofenak 50mg tablet [3] Nifedipine 10mg Tablet(e). [10 caps] Insulin Humalog Kwikpen 300IU/3ml (mice). [1]
Kondisi Saat Keluar Rumah Sakit	Atas Persetujuan Dokter
Instruksi / Tindak Lanjut	kontrol poliklinik rawat jalan Poliklinik Kebidanan tgl: 15-05-2025

Cara Keluar Rumah Sakit	Perbaikan
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)	(TTE) dr. x, Sp. OG